

Briefing de Figuras — Capítulo 12

“Quando Procurar um Especialista — E o Que Perguntar”

DIRETRIZES GERAIS

Paleta e tipografia consistentes com os briefings anteriores:

- Verde escuro (#2D6A4F): zona ótima / segura
- Amarelo-âmbar (#E9C46A): zona de alerta / subótima
- Vermelho suave (#E76F51): zona de risco / alto risco
- Cinza médio (#8D99AE): referência / comparação
- Azul escuro / grafite (#264653): dados do paciente / destaque principal
- Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)
- Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro ou similar). Títulos 14–16pt bold, rótulos 10–12pt regular.
- Formato: vetor (SVG ou AI) + PNG alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px largura).

Nota sobre o capítulo: Cap 12 é o último capítulo de conteúdo do livro, com tom orientativo e narrativo. Precisa de uma única figura — não porque falte conteúdo visual, mas porque o capítulo é conselho, não dado. A figura que faz sentido aqui é a visualização de um contraste conceitual que o livro descreve em palavras desde o Capítulo 1 e que nunca foi mostrado como diagrama.

FIGURA 1 — Dois Modelos de Acompanhamento: O Check-up Convencional e a Avaliação Preventiva

Objetivo comunicacional

Desde o Capítulo 1, o livro contrasta dois modelos. O primeiro é o check-up convencional — a “Medicina 2.0” de Peter Attia: consulta anual curta, painel básico, faixas de referência do

laboratório, “tudo normal”, volte no ano que vem. O segundo é a avaliação preventiva descrita ao longo dos Capítulos 4 a 12: primeira consulta longa, painel ampliado, faixas ótimas, leitura conjunta dos resultados, plano priorizado, ciclos iterativos de acompanhamento.

Esse contraste foi descrito muitas vezes em texto mas nunca foi mostrado como imagem. O Cap 12, que é o capítulo onde o leitor decide qual modelo procurar, é o lugar natural para essa visualização. A figura cristaliza em um diagrama o que o leitor absorveu em onze capítulos de prosa — e funciona como referência visual para levar à próxima consulta.

Posição no capítulo

Inserir **ao final da seção “O Que Esperar de Uma Avaliação Completa”**, imediatamente antes do separador --- que abre “Bandeiras Vermelhas”. Neste ponto, o leitor acabou de ler a descrição do modelo preventivo em detalhe; a figura compara esse modelo com o convencional que o leitor provavelmente já conhece por experiência própria.

Tipo de gráfico

Duas linhas do tempo paralelas empilhadas verticalmente, uma sobre a outra, com o mesmo eixo X (tempo). Não é gráfico estatístico — é diagrama de processo. A comparação visual entre as duas linhas é a mensagem.

Estrutura visual

Layout geral: retângulo vertical (mais alto que largo, para acomodar as duas linhas empilhadas com espaço entre elas). Duas faixas horizontais, cada uma representando um modelo. Faixa superior: check-up convencional. Faixa inferior: avaliação preventiva.

FAIXA SUPERIOR — “Check-up convencional”

Rótulo à esquerda, em cinza médio (#8D99AE), peso bold: *“Modelo convencional”*

Linha do tempo com eixo X representando **um ano** (mês 0 a mês 12). Quatro marcos temporais sobre a linha, cada um como círculo pequeno com rótulo abaixo:

1. **Mês 0 — Consulta anual** (20–30 min) Rótulo abaixo: *“Painel básico: hemograma, glicemia, colesterol total, ECG”*
2. **Mês 1 — Resultados** Rótulo: *“Tudo dentro da faixa de referência → ‘Está tudo normal’”*
3. **Mês 1 a 11 — Vazio** Trecho longo da linha do tempo sem nenhum marco. A linha é pontilhada e em cinza claro — comunicando visualmente que não há acompanhamento entre as visitas anuais. Uma anotação discreta no meio do vazio: *“Sem*

acompanhamento até o próximo ano"

4. **Mês 12 — Próxima consulta anual** Rótulo: *"Ciclo se repete"*

Cor da faixa: fundo cinza claro (#F2F2F2). Marcos temporais em cinza médio. Tom visual neutro, não pejorativo — o check-up convencional não é apresentado como "errado", mas como insuficiente para o que o leitor agora sabe que precisa.

FAIXA INFERIOR — "Avaliação preventiva"

Rótulo à esquerda, em azul escuro (#264653), peso bold: *"Avaliação preventiva ampliada"*

Mesma escala temporal (mês 0 a mês 12), mas com significativamente mais marcos e densidade de atividade. Marcos temporais:

1. **Mês 0 — Primeira consulta** (60–120 min) Rótulo: *"Anamnese profunda: história, hábitos, sono, estresse, expectativas. Termina com pedido de painel ampliado."*
2. **Semanas 2–3 — Exames realizados** Rótulo: *"Painel ampliado: ApoB, insulina, PCR-us, homocisteína, hormônios, tireoide completa, vitamina D, B12, ferritina, cistatina C, microalbuminúria. CAC e MAPA conforme indicação."*
3. **Mês 1 — Consulta de retorno** (60–90 min) Rótulo: *"Leitura conjunta do painel. Faixas ótimas, não apenas referência. Plano construído com o paciente. Regra dos dois: dois focos principais para os próximos meses."*
4. **Mês 4 — Primeiro reteste** Rótulo: *"Reavaliação dos marcadores-alvo. Ajuste de plano."*
5. **Mês 8 — Segundo reteste** Rótulo: *"Reavaliação. Novos marcadores se necessário. Reajuste."*
6. **Mês 12 — Avaliação anual completa** Rótulo: *"Painel completo. Composição corporal. Placar revisitado. Novos dois focos para o próximo ciclo."*

Entre os marcos 3, 4, 5 e 6, a linha é contínua e em azul escuro — comunicando acompanhamento ativo, em contraste com a linha pontilhada do modelo convencional. Pequenas setas entre marcos reforçam o sentido iterativo: testar → intervir → retestar → ajustar.

Anotação entre os marcos 4 e 5, em texto pequeno azul escuro: *"Ciclo iterativo: testar, intervir, retestar, ajustar"*

Cor da faixa: fundo off-white (#FAFAFA) com borda fina em azul escuro.

Elemento visual de contraste entre as duas faixas:

Uma chave ou seta vertical discreta, do lado direito do diagrama, conectando as duas faixas com texto lateral:

“A diferença não é apenas quais exames são pedidos — é a frequência de acompanhamento, a profundidade da leitura, e o fato de que o plano é construído com o paciente e revisado a cada ciclo.”

Código de cores

- Faixa superior (convencional): fundo cinza claro (#F2F2F2), marcos em cinza médio (#8D99AE), linha do tempo pontilhada em cinza claro
- Faixa inferior (preventiva): fundo off-white (#FAFAFA), marcos em azul escuro (#264653), linha do tempo contínua em azul escuro
- Rótulos dos marcos: texto em cinza escuro, tamanho 10–11pt
- Chave comparativa lateral: cinza escuro, texto em itálico
- Sem verde/âmbar/vermelho nesta figura — não é sobre zonas de risco; é sobre processo

Título e legenda

Título: *“Figura 1. Dois modelos de acompanhamento médico — check-up convencional e avaliação preventiva ampliada ao longo de um ano.”*

Legenda: *“O check-up convencional opera em ciclo anual com painel básico e faixas de referência do laboratório. A avaliação preventiva ampliada opera em ciclos iterativos com painel estendido, faixas ótimas, leitura conjunta dos resultados e plano priorizado revisado a cada retorno. O contraste não é de custo ou sofisticação — é de profundidade e continuidade do acompanhamento.”*

O que NÃO fazer

- Não apresentar o modelo convencional como “errado” ou “perigoso” — usar tom neutro, sem cores de alarme na faixa superior. O problema não é o médico convencional; é o design do sistema, como o Capítulo 1 estabeleceu
- Não adicionar nomes de clínicas, marcas, ou logotipos
- Não incluir custos ou comparação de preços — fora do escopo
- Não usar ícones de “certo” (✓) e “errado” (✗) para comparar os dois modelos — reforçaria um tom comercial de “nós somos melhores”

- Não adicionar terceira faixa com “modelo PLENYA” ou qualquer variação institucional
- Não transformar a faixa inferior em propaganda — ela descreve genericamente o que uma boa avaliação preventiva inclui, não o que uma clínica específica oferece
- Não incluir foto ou avatar de médico/paciente
- Não usar setas vermelhas grandes apontando para os “problemas” do modelo convencional — o tom do livro inteiro sobre médicos convencionais é respeitoso (“não quer dizer que seu médico é incompetente”)

RESUMO

#	Figura	Onde entra	O que resolve
1	Dois modelos de acompanhamento (convencional vs. preventivo)	Final da seção “O Que Esperar de Uma Avaliação Completa”	Contraste conceitual descrito em texto desde o Cap 1 e nunca visualizado — cristaliza em diagrama o que o leitor absorveu em onze capítulos e dá referência visual para a decisão de que tipo de profissional procurar

Total: **uma figura**. Capítulo orientativo não precisa de mais. A figura existe porque resolve um problema concreto: um contraste conceitual que o livro inteiro sustenta merece ser mostrado uma vez como imagem, e este é o capítulo certo para isso.